

04 - 4-semiologie du syndrome occlusif

Ça aussi c'est un chapitre qu'on va voir l'année prochaine, l'année prochaine dans la pathologie digestive. On va voir les occlusions. Donc cette année, le but du cours c'est surtout de vous familiariser avec la sémiologie du syndrome occlusif.

Et l'année prochaine on va voir les étiologies et les pathologies, et surtout le cancer du colon, les étiologies étranglées. Alors le syndrome occlusif c'est l'ensemble des manifestations secondaires à l'arrêt du cours des matières et des gaz dans un segment de l'intestin. L'obstacle dans l'occlusion peut être fonctionnel, comme il peut être mécanique.

Fonctionnel, on pense rapidement à l'infection. Une péritonite appendiculaire peut s'accompagner d'un syndrome occlusif et d'une occlusion de niveau hydroélectrique par le mécanisme de l'innéus intestinal. Donc la paralysie de l'intestin, rien que du fait qu'elle est secondaire à l'infection.

Comment elle peut être secondaire à des troubles hydroélectrolytiques ? Un malade qui a une hypokaliémie peut présenter, sur tous les malades de la réanimation, un syndrome occlusif. Mais les obstacles organiques sont les étiologies les plus fréquemment rencontrées. Et cet obstacle organique peut siéger soit au niveau de l'intestin grêle, soit au niveau du gros intestin.

Et on va voir comment faire la différence, bien qu'à l'interrogatoire et par les examens complémentaires, comment faire la part des deux. Donc l'obstacle au niveau du grêle, c'est-à-dire au niveau du gésinome et de l'idiot, le début est souvent brutal. Ce qui fait que l'occlusion intestinale s'accompagne souvent d'un début qui est brutal.

Le météorisme, le ballonnement abdominal, il est discret. C'est pas comme l'occlusion colique. Dans l'occlusion colique, vous allez voir les malades qui arrivent aux urgences avec un ventre distendu, un ventre de matricien, alors qu'au niveau de l'occlusion intestinale, la distension est minime.

Les vomissements sont précoces. Rapidement, le patient commence à vomir et les vomissements sont surtout alimentaires. Alimentaires et vigneux.

Alors que dans l'occlusion basse, c'est-à-dire colique, les vomissements sont nauséabonds et faits caloriques. L'arrêt des matières et des gaz, il est tardif. Pourquoi ? Tout simplement parce que le malade, quand il a une occlusion gésinale ou idiale, il continue à évacuer le segment d'aval, c'est-à-dire le colon.

Il continue à faire la vidange. Il continue à avoir des matières et des gaz. Donc l'arrêt des matières, il est tardif.

L'obstacle, au niveau du sigmoïde, les vomissements, dans ce cas, c'est l'inverse. Les

vomissements sont tardifs. Mais ils sont abondants.

Le météorisme, il est très important. La distension intestinale, elle est très importante. Et ceci s'accompagne d'une altération de l'état général.

Alors la physiopathologie, il est très important. La sécrétion intestinale, l'absorption est diminuée quand le malade a une occlusion. Et donc on aura une stagnation du volume liquémien, ce qui va constituer ce qu'on appelle le troisième secteur dans l'occlusion, dans le syndrome occlusif.

Ce syndrome, ce troisième secteur, il est dû à la stagnation des sécrétions salivaires, des sécrétions gastriques, des sécrétions biliaires et des sécrétions pancréatiques. Ajoutez à ça l'alimentation que parfois les patients continuent à s'alimenter et même ils boivent des boissons par abondance, espérant que l'obstacle va se lever. Dans la mentalité des gens, quand ils ont une occlusion à la matière et les gaz, ils pensent qu'en buvant de l'eau abondamment ou des liquides ou d'autres liquides, ils vont avoir un transi.

Donc le patient va présenter un troisième secteur qui va être responsable de la déshydratation. Ça veut dire que le malade ne bénéficie plus de cette masse liquidienne qui a stagné au niveau de la lumière intestinale, la réabsorption n'est plus là. Donc il y aura une déshydratation, une diminution du milieu intérieur et une hypovolemie, une baisse de la tension artérielle, un coup qui est rapide et donc le patient va présenter un choc hypovolemique secondaire à la constitution de ce troisième secteur.

Maintenant, une fois que vous allez commencer votre stage et voir des occlusions aux urgences, dès que vous voyez un malade chez qui vous posez le diagnostic d'une occlusion intestinale, le réflexe que vous devez avoir, c'est de lui prendre une voie veineuse pour assurer un remplissage, pour éviter l'arrêt cardio-respiratoire secondaire à cette déshydratation et à cette hypovolemie. Donc parmi les urgences, c'est la mise en condition du malade. La mise en condition comprend le rétablissement de la polémie et la réhydratation que vous pouvez assurer rien que par la voie veineuse.

Donc parmi les réflexes que vous devez acquérir, chaque fois que vous allez recevoir un malade qui a une occlusion intestinale aiguë, il ne faut pas penser au diagnostic de la cause, de l'étiologie. Peu importe que ce soit une tumeur, une hernie intanglée, etc. Mais dans votre esprit, il faut avoir le réflexe de prendre la voie veineuse parce que vous allez lui éviter l'arrêt cardio-respiratoire secondaire à cette hypovolemie.

Alors les occlusions, voici les raisons de l'occlusion. La dernière fois dans le cours, on a vu les hernies étranglées. C'est la diapositive qui est à gauche.

Vous voyez par exemple une hernie ombilicale dans laquelle un bout d'intestin s'est incarcéré dans le sac herniaire et s'est étranglé. C'est-à-dire qu'il va entraîner une occlusion intestinale secondaire à l'étranglement herniaire. Alors que l'autre patient, il a une hernie inguinale.

L'intestin s'est incarcéré dans une hernie oblique externe herniaire et il va produire un tableau d'occlusion intestinale. Ici, c'est une diapositive qui montre le sac herniaire, peu importe son siège. Et vous voyez l'intestin qui souffre dans ce sac à cause de l'étranglement.

Il y a un problème vasculaire. Vous voyez que l'intestin, il est bleuté, il est cyanosé. Une autre cause des occlusions, ce sont les rides et les adhérences.

Les rides et les adhérences. C'est une pathologie qui est très bizarre, très mystérieuse. Chaque individu, chaque patient, chaque personne qui a eu un jour une intervention chirurgicale, il est exposé le restant de sa vie à faire une occlusion sur rides et adhérences.

C'est quoi les rides et les adhérences ? Ce sont les intestins qui vont s'accoler les uns par rapport aux autres. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun procédé médical qui permet d'éviter les rides et les adhérences dans le restant de la vie de la personne. C'est-à-dire que la survenue des rides et des adhérences, la durée est différente selon les patients.

Il y a des patients qui vont présenter des rides et des adhérences dans deux semaines. D'autres, un mois après. L'autre, six mois.

L'autre, une année après. L'autre, trente ans après une intervention pour une appendicite qui va présenter une occlusion sur ride et des adhérences. Et l'autre, il ne va jamais la présenter.

Vous voyez ? Donc ça dépend des patients, des individus, etc. C'est variable. Et on ne peut pas prévoir ou prédire est-ce que le malade va faire des rides et des adhérences ou pas.

D'accord ? On peut réopérer quelqu'un qui a eu une intervention chirurgicale dans le passé et trouver que son endommagement n'est ni niquel, ni ride, ni adhérence. Et on peut opérer quelqu'un d'autre. Mais on va trouver que tous les intestins sont ride et adhérents les uns par rapport aux autres, par rapport à la paroi.

Mais il ne va jamais présenter un syndrome occlusif, malgré qu'il a des adhérences. Donc c'est une pathologie qui est mystérieuse selon les individus, chacun comment il va la manifester. Un autre mécanisme que vous voyez ici, c'est la vaginisation.

Très bien. C'est l'introduction d'un segment intestinal, c'est la rentrée du segment intestinal dans le segment basal. C'est une pathologie d'invagination.

Il y a deux types d'invagination. Il y a l'invagination intestinale primitive qui se voit chez les bébés de 1 mois jusqu'à 2 ans. Cette pathologie vous allez la voir dans les services de chirurgie infantile.

C'est une pathologie qui survient primitive parce qu'il n'y a pas d'adhésions sous-jacentes. Alors que chez l'adulte, c'est des invaginations qui ne sont pas primitives mais secondaires. Quand on opère non chirurgien, quand on opère une invagination, on doit toujours chercher et réséquer le

boudin.

Le boudin, c'est cette masse formée par l'invagination. On va le réséper et l'adresser à les amas anaphates. Et toujours les amas anaphates, il nous dit qu'il y a une lésion sous-jacente.

Un poly, un myone, un lipone, etc. Toujours il y a une lésion sous-jacente ou un diverticule de métel. Donc tout ce que vous devez retenir à propos de l'invagination, chez les bébés de moins de 2 ans, elle est toujours primitive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion sous-jacente.

D'ailleurs, si vous faites le diagnostic, si vous êtes de garde dans un service de pédiatrie et vous recevez un enfant, un bébé de moins de 2 ans avec des cris, des douleurs, de l'agitation et vous faites l'échographie et vous trouvez un boudin d'invagination, si le diagnostic est fait précocement, vous ne pouvez rien que par une réduction, par un tube et une insufflation transventales, réduire l'intestin sans avoir recours à la chirurgie. D'où l'intérêt d'un diagnostic précoce avant l'installation de la nécrose chez le bébé, chez l'enfant de moins de 2 ans qui a une invagination intestinale aiguë. Donc chaque fois que vous recevez un malade avec une invagination intestinale aiguë, tout l'intérêt d'un diagnostic précoce.

Donc soit vous allez faire une échographie, soit un scanner pour confirmer le diagnostic et vous allez rapidement hospitaliser le patient et grâce à une usine transrectale, vous allez insuffler de l'air pour espérer réduire cette hausse intestinale. D'ailleurs le résultat est spectaculaire. Dès que vous allez réduire l'intestin, le petit enfant n'a plus mal.

Il n'a plus ces cris et ces agitations. Dès que sa maman le reprend dans ses bras et lui donne la tété, il va se calmer. D'accord ? Donc le résultat est spectaculaire, mais à condition que le diagnostic soit fait rapidement et avant l'installation de la nécrose.

Parce que même dans l'invagination, si le diagnostic est tardif, il y aura une nécrose intestinale par souffrance et ischémie de chevaux intestinal. Et puis le dernier mécanisme, c'est le volbulus. Le volbulus le plus fréquemment rencontré en pathologie, c'est le volbulus du sigmoïde.

Le sigmoïde, il faut savoir que sa longueur est variable. Il y a des gens qui ont 30 cm de longueur, 40, l'autre il a 50 cm et il y a même des gens qui ont 80, 90, 1 mètre de longueur de cette boucle sigmoïdienne. Et plus la longueur est longue, comment on appelle ce sigmoïde ? Dolico.

Donc le volbulus du sigmoïde, il est favorisé par le dolico sigmoïde. C'est l'excès de longueur de la lance sigmoïdienne. Donc l'excès de longueur favorise le volbulus du sigmoïde.

De point de vue fréquence, le segment intestinal le plus fréquemment concerné, c'est le sigmoïde. Mais le volbulus du sigmoïde peut intéresser le transverse. Même le transverse, s'il a un excès de longueur, un dolico transverse, il peut se tordre autour de son axe vasculaire et entraîner un syndrome oblusif.

On peut avoir un volvulus du secambre. Le secambre, parfois, s'il est mal fixé, on peut avoir un volvulus du secambre. Et puis on peut avoir le volvulus de tout le grain.

Ça s'appelle le mesenterre commun. Donc il y a des gens qui ont un mesenterre qui est trop long, excès de longueur du mesenterre, et ils peuvent se tordre et donner une oblusion intestinale très aiguë par torsion du mesenterre. Et cette pathologie, on va l'appeler mesenterre commune.

Vous avez des questions à propos des mécanismes, des occlusions mécaniques ? Cette diapositive, c'est pour vous montrer l'intérêt de l'inspection. Donc ce malheur, c'est qu'il est porteur d'une laparotomie antérieure, des cicatrices. Chaque fois qu'un patient est porteur d'une cicatrice d'incision médiane, il risque d'être porteur de quoi ? Bride et adhérence.

Dans l'examen clinique, il doit s'interroger sur le début. Il est brutal dans les cas de stranglement. Un volvulus, c'est un stranglement du mesenterre.

Donc le début, il est brutal. C'est pas la même chose que le début lors d'une tumeur. Une tumeur, il a besoin de plusieurs semaines, plusieurs mois, avoir plusieurs années pour s'installer.

L'évolution par crise ou par intermittence, les vomissements peuvent être précoces. Quand le malade a une vision qui dit que j'ai des vomissements qui sont précoces, vous pensez à une vision haute, haute intestinale. Si les vomissements sont actifs, c'est une vision colique.

Les abondants ou non, s'ils sont abondants, c'est en faveur d'une occlusion colique, basse. S'ils sont peu abondants, c'est haut. Alimentaires, c'est en faveur du grêle, très bien, d'une occlusion.

Et vous voyez que l'interrogatoire finalement, malheureusement que sous-estiment pas mal de médecins, vous pouvez avancer rapidement dans votre diagnostic. Rapidement, grâce au recueil de ces bonnets, vous pouvez avancer. Et même le choix de l'examen complémentaire, vous allez demander l'examen ciblé et qui va vous rendre service rapidement.

Alors cliniquement, il faut également rechercher les signes généraux. Au début, l'état général est conservé. Mais rapidement, le malade va entrer dans le choc hypopolémique.

L'abdomen peut être ballonné, météorisé. On peut observer, parfois si le patient est mince, velte et sportif, on peut même voir des mouvements périspatiques sous la peau. On peut observer, comme on l'a vu tout à l'heure, une cicatrice de médiane, cicatrice de la parotomie.

Mais surtout, il faut avoir cette règle, c'est de chercher, dans les orifices herniers, il faut chercher une hernie étranglée. Ça c'est une règle, c'est une théorie. Chaque fois que vous avez un syndrome conclusif, la première des choses à éliminer, c'est l'étranglement hernier.

Donc dès que je reçois le malade, directement l'orifice ombilical, la ligne blanche, les plis inculminaux, pour éliminer une hernie lui étranglée. La palpation va montrer une résistance de la

paroi élastique. Et puis, n'oubliez jamais les orifices herniers.

A la palpation, vous allez soit noter un tympanisme diffus ou localisé. Et puis, il ne faut pas oublier l'auscultation. On peut s'entendre des bruits d'eau aérique, s'entendre un silence total.

Soit que le patient a trémi, soit qu'il est rentré dans des complications beaucoup plus graves, telles que la peritonite associée, etc. N'oubliez jamais le toucher rectal. Normalement, dans une occlusion organique, l'encre rectale est éliminée.

Donc, sur le plan sémiologique, plus douleur, plus vomissement, plus altération de l'état général, plus météorisme, on ne voudrait pas de vide, d'énigme ou d'eau aérique. C'est en faveur d'une occlusion intestinale. Le tympanisme, c'est l'orgue de la percussion qui entend de l'air.

Le tympanisme crée une jambe. Si tu prends par exemple un vocal vide, ça c'est un panique ou un mal ? C'est un panique. C'est un panique.

Mal, c'est le mur. Et encore, parce que ce mur n'est pas renforcé par l'air. Donc, à partir du son, il faut s'habituer à le faire.

Si la structure est mal, mal veut dire qu'elle est pleine. La structure est pleine. Au sonore.

Et même un mur, tu peux savoir s'il est mal au sonore. Si par exemple je tape la région à la ligne, est-ce que ce mur est solide, renforcé ? Il est solide. Il est solide.

Donc il est un panique. Si par exemple je choisis la poutre, là où il y a le fer, etc., ça va être mal. D'accord ? Donc, un panique veut dire que soit il y a de l'air dans l'intestin ou bien il y a du liquide.

C'est mal ? D'accord. Donc il faut avoir un oreille expert et s'habituer à faire la part entre les choses et les structures. Est-ce que c'est mal ou c'est le sonore ? Votre question ? Bien sûr, vous allez commencer par les radiaux.

L'ASP, deux roues. Vous demandez l'ASP, deux roues. Face, très bien.

Donc ici, vous avez des niveaux, des niveaux reliques plus larges qu'haut, centraux, étagés, et même collés. Donc c'est une obligation collique, gréopolique. Voici un niveau, un deuxième, étagé, centraux, plus large qu'haut.

Voici une obligation collique. Ils sont plus hauts, plus larges, périphériques. D'accord ? Voici une TDM.

La TDM va vous permettre de faire le bien possible. Vous faites aussi des chirurgies. Donc ici, on voit l'obstacle.

Ici, on voit l'obstacle. Là aussi, on voit l'obstacle. On voit la distorsion des anses, qui sont pleines

de liquides.

Donc la TDM, dans la majorité des cas, lorsqu'elle est demandée en avance pour un symptôme conclusif, elle nous donne même, bien sûr elle confirme les possibles conclusions, mais le but de la TDM, c'est de rechercher l'étiologie. Est-ce que c'est une tumeur ? Est-ce que c'est un infarctus ? Est-ce que c'est une hernie anglaise ? Etc. Donc la TDM permet, dans 70 à 95%, de retenir un diagnostic précis.

Et c'est ça le but de la TDM aujourd'hui, je pense. Voici l'exploration chirurgicale d'une infusion avec une strangulation qui montre une écrose intestinale de ces deux anses intestinales où la couleur, vous voyez la différence de couleur, bleu à noire, ici, par rapport à... Donc la décision ici, ça va être une réfection à l'astropose. Réfection à l'astropose.

Pardon. En soi-disant, elle est là depuis deux jours, et il faut qu'on la vérifie, il n'y en a pas beaucoup. Donc elle est écroisée, il faut la vérifier.

Donc ça, c'est le constat final. Donc là-bas, vous imaginez qu'on a pris cette peau bleue quand on est sûr qu'il n'y en a pas. Et puis, lorsque vous avez cette couleur comme ça, c'est qu'elle est déjà écroisée.

Donc il faut faire une réfection à l'astropose. Et la décision ne dépend pas uniquement de l'écrose. Si, par exemple, on avait du liquide, une téléphonique, on ne pourra pas faire l'astropose.

Donc la sanction, la sanction finale, elle est très importante. Très importante pour le geste chirurgical, mais aussi pour le patient, pour son entourage, pour sa famille. Parce que faire une réfection à l'astropose, ce n'est pas la même chose que de faire une réfection à Houston.

Donc le résultat final, c'est l'importance de prendre des photos pour les familles, pour le malade. Parce que maintenant, si vous faites de la chirurgie, vous commencez toujours à prendre des photos en fait opératoire. Parce que c'est difficile de convaincre le patient et son entourage.

Si, par exemple, il y a du liquide septique, s'il y a un étrangement purulent dans la cavité abdominale, il faut montrer ça au patient pour lui dire que c'était impossible de faire une suture et qu'on va faire une chirurgie permanente. En attendant la guérison de la période, le malade, bien sûr, il va être provoqué en charge par les antibiotiques. À un certain moment, un mois, un mois et demi jusqu'à deux mois, et le réopérer pour faire le répartition de la continuité.

D'accord ? Donc la sanction, elle est très importante. Ici, je peux vous dire que la sanction, c'est une réfection à l'astropose. Les mécanismes, on les a vus tout à l'heure, on peut avoir une paralysie de tout l'intestin grêle, c'est l'hidéus paralytique, qui peut se voir au cours des périodolites, des troubles métaboliques.

Les signes généraux, c'est l'inflammation du périodoine, le météorisme, il est très important, et les

niveaux hydro-aériques sont aussi bien coliques que grêles. Le robulus, c'est la portion autour de l'axe vasculaire, ce mécanisme, on le voit dans les débris, on peut le voir dans les tremblements aériens. Le risque de l'écrose, il est là, il est très important.

C'est une question d'heures, maximum 6 heures. Si une maladie papillongère ou l'aémie est englée, au-delà de 6 heures, les conséquences sont fatales. Il va y avoir une réjection de cette branche qui est écrosée.

La brutalité du début, la douleur qui est importante, les rides et les adhérences, le robulus et les tremblements aériens. Des questions ? Proche mécanisme de reconstruction de la lumière intestinale, le début, il est soi-disant progressif, il n'est pas aussi brutal que dans l'aémie englée ou bien dans la strangulation par ride. Conservation de l'état général, les ondulations péristaltiques, parce que le sédiment s'hypertrophie même pour lutter contre la stérose.

Le météorisme, il est diffus, et l'écrose, ça peut être une tumeur ou une stérose un temps à voir. Surtout de l'idée cardinale, une stérose dans le cadre de la maladie de Crohn ou dans le cadre du tuberculose. Donc en conclusion, on va dire que l'ondulation intestinale c'est une maladie aussi bien locale que générale.

Donc il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'étiologie, il faut penser à cet état de déshydratation, cette hypovolemie, pour la corriger, pour peut-être préparer le patient aux examens complémentaires. Parce qu'avant de renvoyer le malade faire un scanner, il peut rester des heures et des heures en attendant qu'il fasse la TDR, et il peut passer par un arrêt cardio-respiratoire, secondaire à la déshydratation. Donc la première des choses, c'est la mise en condition, c'est prendre des voies veilleuses, des gestes faciles, le remplissage d'une sonde vasogastrique pour éviter le Mendelssohn, les vomissements et l'inhalation des vomissements.

Donc le mettre en condition avant de penser à un diagnostic étiologique. Donc le bon être, le syndrome occlusif, le siège, le type et le mécanisme. Vous avez des questions ?